

Massothérapie et orthothérapie

KRKT:TIDE · L'éducation sur le diabète de type 1 de KRKT

En cas d'urgence. Une personne vivant avec le type 1 qui est confuse, très somnolente, incapable d'avaler ou inconsciente : composez le 911.

De l'éducation, pas un avis médical. Chaque dose, ratio et cible se décide avec votre équipe de soins en diabète.

Massothérapie et orthothérapie

Ce que la thérapie manuelle peut et ne peut pas faire avec le type 1, ce qui change sur la table, et quoi dire au thérapeute d'abord.

Cette section s'adresse aux personnes vivant avec le diabète de type 1 qui pensent consulter en massothérapie, en orthothérapie ou dans une autre thérapie manuelle — et aux massothérapeutes et orthothérapeutes qui les reçoivent.

Commençons par rassurer : la plupart des personnes vivant avec le type 1 peuvent réserver un massage comme tout le monde. Ce qui change tient en une courte liste de choses pratiques. Le massage, la chaleur et le travail musculaire peuvent faire agir plus vite une dose d'insuline récente. Un capteur de glucose en continu peut afficher une fausse baisse quand on appuie dessus, et l'huile empêche son adhésif de tenir. Des pieds engourdis ne peuvent pas avertir le thérapeute quand la pression ou la chaleur est trop forte. Et au Québec, choisir un thérapeute fonctionne autrement qu'ailleurs au Canada, parce que ni la massothérapie ni l'orthothérapie ne sont des professions réglementées.

Les pages qui suivent présentent qui fait quoi et ce que le massage peut honnêtement promettre, l'insuline et l'hypoglycémie sur la table, les capteurs et les pompes, ce qui change avec des complications, quoi dire au thérapeute, et une page écrite pour les thérapeutes eux-mêmes. Une [carte imprimable](#) à remettre à la première visite est aussi offerte.

De l'éducation, pas un avis médical. Où injecter, quand, et combien de temps éviter une zone se décident avec votre équipe de soins en diabète.

Sources : Diabète Québec, « Spa, sauna et massothérapie » · Fédération québécoise des massothérapeutes (FQM) · FIT Canada 2020 · Larkin et coll., Diabetes Care 2014 (DCCT/EDIC)

Qui fait quoi, et ce que le massage peut honnêtement promettre

Massothérapeutes, orthothérapeutes, kinésiologues et physiothérapeutes au Québec, pourquoi on consulte avec le type 1, et ce que les données appuient.

Bien des choses qui circulent en ligne sur le massage et le diabète promettent plus que ce que montre la recherche. Cette page démêle qui sont les différents thérapeutes au Québec, pourquoi les personnes vivant avec le type 1 finissent souvent par en consulter un, et quels bienfaits tiennent vraiment la route.

Quatre titres sur la porte de la clinique

Massothérapeute. Le massage thérapeutique. La massothérapie n'est **pas réglementée** au Québec : il n'existe aucun ordre professionnel, et le titre n'est pas protégé. Les normes viennent de l'association dont la personne est membre. L'Ontario et la Colombie-Britannique réglementent la massothérapie; le Québec, non.

Orthothérapeute. La massothérapie jumelée à la kinésithérapie (thérapie par le mouvement), pour les douleurs musculaires et la raideur articulaire. C'est une spécialisation qui suit la formation en massage — environ 1 000 à 1 300 heures au total, selon l'école. L'orthothérapie n'est **pas réglementée** non plus.

Kinésiologue. L'exercice comme traitement, représenté par une fédération (FKQ). Le Québec a annoncé en juin 2026 que la kinésiologie sera intégrée à un ordre professionnel, mais ce n'est pas encore en vigueur.

Physiothérapeute. **Réglementé** par l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ), qui tient un répertoire public. Le premier choix pour une blessure, une capsulite ou tout ce qui demande un diagnostic.

Au Québec, le *kinésithérapeute* est un thérapeute du mouvement non réglementé. Ce n'est pas l'équivalent du *masseur-kinésithérapeute* français, qui, en France, est l'équivalent réglementé du physiothérapeute. Les personnes qui ont vécu en France confondent souvent les deux.

Pourquoi les personnes vivant avec le type 1 consultent

Les problèmes aux mains et aux épaules sont fréquents après de nombreuses années de type 1, et on les prend souvent pour de simples effets de l'âge.

66 %

des 1 217 adultes de l'étude DCCT/EDIC — en moyenne 31 ans de type 1 — avaient au moins un problème à la main ou à l'épaule

31 %

capsulite (épaule gelée) : une épaule douloureuse qui raidit peu à peu

30 %

syndrome du canal carpien : doigts engourdis ou qui picotent, souvent la nuit

28 %

doigt à ressaut : un doigt qui accroche ou se bloque en pliant

22 %

mains raides — impossible de joindre les paumes à plat (le « signe de la prière »)

La maladie de Dupuytren touchait 9 % des participants. La capsulite est environ cinq fois plus probable avec le diabète que sans.

Ces chiffres viennent de personnes diagnostiquées il y a des décennies, et on ne sait pas encore à quel point ces problèmes sont fréquents avec les soins d'aujourd'hui. L'explication principale : avec les années, le glucose rigidifie lentement le collagène (glycation) — une question de temps et d'exposition, pas un jugement sur les efforts. Dans l'essai d'origine, les personnes ayant reçu un traitement intensif et celles ayant reçu un traitement conventionnel avaient des taux semblables : 64 % contre 68 %, une différence non significative.

Ce que le massage peut honnêtement promettre

Assez bien appuyé. Se sentir plus calme. Une méta-analyse de 37 essais a montré qu'une seule séance de massage réduit l'anxiété, la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Pour la capsulite chez les personnes vivant avec le diabète, la mobilisation articulaire jumelée à l'exercice a eu le plus grand effet dans 8 essais — même si les données sont de faible qualité.

Contesté. « Le massage fait baisser les hormones de stress. » Une revue rapportait une baisse du cortisol d'environ un tiers après un massage. Une méta-analyse plus rigoureuse, qui comparait les groupes massés à des groupes témoins, n'a trouvé aucun effet mesurable sur le cortisol. Et le stress lui-même fait varier la glycémie différemment selon les personnes vivant avec le type 1 : à la hausse chez certaines, à la baisse chez d'autres, et pas du tout chez d'autres encore.

Non démontré. Traiter le diabète. Quelques petites études — surtout chez des enfants, la plupart sans véritable groupe de comparaison — ont vu la glycémie baisser après des séances de massage. L'explication la plus probable : le massage accélère l'absorption de l'insuline déjà injectée. C'est une raison de vérifier sa glycémie, pas une thérapie. Aucune donnée solide ne montre non plus que le massage prévient ou traite les complications en « améliorant la circulation », et aucune ligne directrice sur le diabète ne le recommande.

Niveau de preuve

Toutes les affirmations sur le massage et la glycémie reposent sur des données de faible qualité : de petites études courtes, la plupart sans groupe témoin, plusieurs avec d'anciennes insulines.

Alors, on y va parce que ça fait du bien, que ça détend et que ça aide à bouger — pas pour traiter le diabète. C'est une excellente raison de réserver.

Sources : Office québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique · Mon Réseau Plus (RMPQ) · RITMA · Gouvernement du Québec, annonce du 16 juin 2026 · Larkin et coll., Diabetes Care 2014 (DCCT/EDIC) · Zreik et coll., Muscles Ligaments Tendons Journal 2016 · Moyer et coll., Psychological Bulletin 2004 · Moyer et coll., Journal of Bodywork and Movement Therapies 2011 · Field et coll., International Journal of Neuroscience 2005 · Alsubheen et coll., Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2019 · Ezzo et coll., Diabetes Spectrum 2001 · Sajedi et coll., Acta Medica Iranica 2011 · Wiesli et coll., Diabetes Care 2005

Sites d'insuline, chaleur et hypoglycémie sur la table

Pourquoi le massage, la chaleur et le travail musculaire accélèrent une dose d'insuline récente, et comment vérifier, se préparer et traiter une hypo.

C'est la partie du massage qui est vraiment différente avec le type 1. Frotter, chauffer ou faire travailler le muscle sous une injection récente fait passer l'insuline plus vite dans le sang — et une séance est aussi un moment où une hypo passe facilement inaperçue. Cette page explique les deux, et quoi faire.

L'insuline file plus vite sous une main qui travaille

On mesure cet effet depuis la fin des années 1970.

~6x

absorption plus rapide de l'insuline quand le site d'injection a été massé 30 minutes — et la glycémie a baissé plus vite

110 %

d'absorption en plus après deux séances de sauna, avec une glycémie de 3,0 à 3,3 mmol/L plus basse

135 %

d'absorption en plus dans les dix premières minutes d'exercice des jambes après une injection dans la cuisse

Les pierres chaudes, les compresses chaudes et les spas agissent comme le sauna : la chaleur accélère l'absorption.

Il s'agit de petites études — neuf volontaires dans la principale étude sur le massage — faites avec d'anciennes insulines humaines. Personne n'a mesuré directement l'effet d'un massage sur un analogue à action rapide ou sur un site de pompe. Les études sur la chaleur appliquée au site de pompe avec une insuline à action rapide vont dans le même sens : mieux vaut donc présumer que l'effet s'applique.

FIT Canada, la référence canadienne sur la technique d'injection, déconseille de masser le site juste avant ou après une injection, parce que l'action de l'insuline devient imprévisible.

Quoi faire

- N'injectez pas dans une zone qui va être travaillée.
- Demandez au thérapeute d'éviter les sites d'injection récents et le site de votre pompe.
- Pas de chaleur — pierres, compresses, serviettes chaudes — sur ces zones.

La durée pendant laquelle éviter une zone dépend de l'insuline. Votre équipe de soins en diabète peut vous dire combien de temps la vôtre reste active.

L'hypo sur la table

Immobile, détendu, les yeux fermés, le visage dans l'appui-tête : les premiers signes d'une hypo passent facilement inaperçus, ou ressemblent à de la détente. Diabète Québec prévient que la glycémie peut baisser de façon inattendue pendant un massage. Aucune étude n'a examiné directement l'hypoglycémie pendant un massage : ce qui suit relève donc de la prudence plutôt que des données.

Avant. Vérifiez votre glycémie. Si vous êtes bas ou en baisse, traitez et attendez, ou déplacez le rendez-vous. Mangez comme d'habitude — n'arrivez pas l'estomac vide.

À portée de main. Gardez du sucre rapide au bord de la table ou dans la main, pas dans un sac à l'autre bout de la pièce. Convenez avec le thérapeute d'un mot qui veut dire « arrêtez, j'ai besoin de sucre ». Bien des personnes vivant avec le type 1 n'oseront pas interrompre une séance qu'elles paient; ce mot leur en donne la permission d'avance.

Après. Vérifiez de nouveau avant de conduire. La Fédération québécoise des massothérapeutes (FQM) suggère de vérifier avant et après au moins les deux ou trois premières séances, pour apprendre comment votre glycémie réagit.

Si une hypo survient pendant la séance

- On arrête. On s'assoit lentement.
- 15 g de sucre rapide, puis on revérifie après 15 minutes.
- Si la personne est inconsciente ou fait une convulsion, composez le 911 et ne donnez rien par la bouche.

Voir traiter une hypo pour savoir à quoi correspondent 15 g.

Commencez simplement

Si c'est votre premier massage avec le type 1, commencez par un massage de détente plutôt qu'un travail en profondeur, et notez votre glycémie avant et après, avec votre dernière dose et l'endroit où vous l'avez injectée. Deux ou trois séances de notes montrent votre propre tendance — ce qui vaut mieux que n'importe quelle règle générale.

Sources : Linde, Diabetes Care 1986 · Koivisto, BMJ 1980 · Koivisto et Felig, NEJM 1978 · Raz et coll., Clinical Therapeutics 2009 · Landau et coll., Diabetes/Metabolism Research and Reviews 2014 · FIT Canada, Forum pour la technique d'injection 2020 · Diabète Québec, « Spa, sauna et massothérapie » · FQM, « Masser une personne diabétique » · Diabète Canada

Capteurs, pompes, et quand reporter

Fausse hypes par compression, huiles et adhésifs, garder la pompe à portée de main, et les rares situations où le rendez-vous doit attendre.

La table de massage est l'un des rares endroits où les mains de quelqu'un d'autre passent une heure près de votre capteur et de votre cathéter. Cette page explique ce qui peut arriver aux appareils pendant une séance, et la courte liste de raisons de déplacer le rendez-vous.

Votre capteur et votre pompe sur la table

Fausses hypos par compression

Une pression sur le capteur de glucose en continu — couché dessus, ou une main qui appuie — peut afficher une baisse soudaine qui n'est pas réelle. Confirmez un chiffre surprenant au glucomètre avant d'agir.

Dans une étude où des volontaires portaient plusieurs capteurs à la fois, les lectures erronées soudaines étaient fortement liées au fait d'être couché sur les capteurs; la plupart étaient des baisses. Les utilisateurs parlent de « compression lows »; la littérature scientifique, d'atténuation du signal par la pression. Tous les guides des fabricants disent la même chose : quand la lecture ne correspond pas à ce que vous ressentez, vérifiez au glucomètre.

L'inverse compte tout autant : ne balayez pas une vraie hypo du revers de la main en présumant que c'est la compression. Dans le doute, piquez.

Huiles et lotions. Dexcom et Abbott déconseillent tous deux d'appliquer une lotion près du capteur, parce que l'adhésif ne tient plus. L'huile de massage pose le même problème. Aucun des deux fabricants ne le dit précisément pour les cathéters de pompe, mais la même logique s'applique. Demandez au thérapeute de laisser une main de largeur de peau libre, sans huile, autour de chaque appareil.

Montrez où ils sont. Montrez votre capteur et votre cathéter avant de vous allonger. Les draps, les étirements et la friction sont ce qui les arrache.

Pompes. Gardez la pompe à portée de main. Si vous la débranchez pour la séance, convenez avec votre équipe de soins en diabète de la durée acceptable — et rebranchez-la avant de partir.

Quand déplacer le rendez-vous

Quelques situations demandent de reporter :

- **Cétones élevées.** Cétones sanguines à 0,6 ou plus, ou glycémie élevée avec malaise. C'est votre plan de jours de maladie, pas un massage.
- **Une hypo grave dans les dernières 24 heures** — une hypo qui a demandé l'aide de quelqu'un. Vos défenses sont affaiblies pour la suivante.
- **Plaie ou infection** dans la zone à traiter — plaie ouverte, ulcère, ampoule ou infection, surtout aux pieds.
- **Fièvre ou maladie aiguë.** Les jours de maladie passent en premier. Réservez de nouveau une fois revenu à vos valeurs habituelles.

La FQM nomme le diabète mal équilibré, les épisodes d'hypoglycémie et les ulcères ou plaies parmi les contre-indications au massage. Reporter en cas de cétones ou d'hypo grave récente relève du bon sens clinique plutôt que d'une règle publiée sur le massage.

Tout le reste est une raison d'en parler, pas de rester à la maison

Diagnostic récent, pompe ou injections, complications existantes : rien de tout cela n'empêche un massage. Ce sont des raisons d'en parler au thérapeute.

Certains conseils qui circulent en ligne exigent l'accord du médecin avant chaque rendez-vous. La FQM suggère plutôt de consulter votre médecin en cas de doute — par exemple, avec des problèmes de circulation ou des complications dont vous n'êtes pas sûr. La plupart des personnes vivant avec le type 1 n'ont pas besoin de permission pour se faire masser.

Sources : Mensh et coll., Journal of Diabetes Science and Technology 2013 · Guide d'utilisation Dexcom G7 · Guide d'adhérence Abbott FreeStyle Libre 2 (Canada) · Guide d'utilisation Medtronic Guardian 4 · FQM, « La massothérapie chez la personne diabétique » (2018) · Diabète Québec, « Spa, sauna et massothérapie »

Pieds engourdis, articulations raides et peau

Le massage avec une neuropathie, qui consulter pour une épaule ou une main raide, les bosses aux sites d'insuline, et se relever en sécurité.

Les complications n'empêchent pas le massage. Les personnes qui ont les pieds engourdis ou une épaule raide profitent souvent d'une thérapie manuelle, à très faible risque, pourvu que le thérapeute sache quoi adapter. Cette page présente ces adaptations.

Si vos pieds ou vos mains ont perdu de la sensibilité

La neuropathie enlève le seul signal de sécurité sur lequel compte le massage : vous qui dites « c'est trop ». Le thérapeute doit donc juger à votre place.

- **Pression large.** Sur les zones engourdies, demandez une pression large, à pleine main, plutôt qu'un travail profond en points ou des étirements énergiques.
- **Regardez après.** Refaites après la séance l'examen des pieds que vous faites déjà chaque jour : rougeurs, ampoules, peau abîmée.
- **Faites la carte.** Dites au thérapeute où l'engourdissement commence et finit. C'est plus utile que le mot « neuropathie ».

Pas de chaleur sur la peau engourdie

Pierres chaudes, compresses et serviettes chaudes peuvent brûler une peau qui ne les sent pas. Diabète Canada conseille déjà de vérifier l'eau du bain avec la main pour la même raison.

Il y a aussi un petit signal positif. Dans un essai auprès de 60 personnes vivant avec le diabète de type 2 et une neuropathie, deux semaines de massage thaï des pieds ont amélioré l'équilibre et les tests de sensibilité. L'étude était petite, courte et portait sur le type 2 : c'est encourageant, pas démontré.

Épaules et mains raides : qui consulter

La capsulite, le syndrome du canal carpien, le doigt à ressaut et les mains raides sont tous fréquents après de nombreuses années de type 1 (voir [qui fait quoi](#)). Les orthothérapeutes les voient souvent en premier, parce qu'on consulte pour « une épaule raide ».

D'abord un diagnostic. Une épaule qui raidit sur des semaines, un doigt qui accroche, des doigts engourdis la nuit : voyez votre médecin ou un physiothérapeute, pas seulement un massothérapeute.

Ce qui est le mieux appuyé. La mobilisation articulaire jumelée à l'exercice, par un physiothérapeute ou un thérapeute formé, a eu le plus grand effet dans une revue de huit essais auprès de personnes vivant avec le diabète. Les données sont de faible qualité, et la récupération est souvent plus lente avec le diabète — prévoyez que ça prenne du temps.

La place du massage. En complément, pour la tension musculaire et le confort. Un travail doux d'amplitude compte plus que la force.

Si on vous propose une infiltration. Une injection de cortisone dans l'épaule ou la main peut faire monter la glycémie pendant un certain temps. Planifiez les jours suivants avec votre équipe de soins en diabète — voir [les médicaments qui font monter la glycémie](#).

Bosses, peau et se relever

Bosses aux sites d'insuline. Des bosses caoutchouteuses sous la peau aux sites d'injection ou de pompe — la lipohypertrophie — touchent environ le tiers des personnes vivant avec le type 1, selon les études regroupées. Le thérapeute les remarque parfois avant vous. L'insuline injectée à ces endroits agit de façon imprévisible : parlez-en à votre équipe. C'est une question de rotation des sites, pas un échec personnel.

Peau. Évitez toute plaie, lésion, ampoule ou infection dans la zone traitée. Hydrater des pieds secs, c'est bien — mais pas entre les orteils.

Se relever. Certaines personnes qui vivent avec le type 1 depuis longtemps ont des étourdissements en se levant. Asseyez-vous un moment au bord de la table, puis levez-vous lentement.

Yeux. Chirurgie oculaire récente ou rétinopathie avancée? Demandez à votre spécialiste des yeux combien de temps vous pouvez rester à plat ventre.

Sources : Embil et coll., Lignes directrices de pratique clinique de Diabète Canada, chapitre sur les soins des pieds 2018 · Chatchawan et coll., Medical Science Monitor Basic Research 2015 · Alsubheen et coll., Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2019 · Tang et Tan, Medicine 2024 · Deng et coll., Journal of Diabetes Investigation 2018 · FQM, « Masser une personne diabétique » (2007)

Avant la séance : quoi dire et qui choisir

Les mots à dire au thérapeute, quoi apporter, comment vérifier un thérapeute au Québec, les reçus d'assurance, l'impôt et la RAMQ.

L'essentiel de la sécurité d'un massage avec le type 1 tient en deux minutes de conversation avant de vous allonger. Cette page vous donne les mots, et explique comment choisir un thérapeute au Québec, où le titre seul dit très peu de choses.

Quoi dire au thérapeute

Dites ceci, ou remettez la [carte imprimable pour le thérapeute \(PDF\)](#) — deux exemplaires sur une page lettre, avec des espaces à remplir :

1. J'ai le diabète de type 1 et je prends de l'insuline — pompe / injections.
2. Mon capteur est **ici**, et le site de ma pompe est **ici**. Pas d'huile, de pression ni d'étirement dessus, s'il vous plaît.
3. Ma dernière insuline : à ___, dans ___. Évitez cette zone, et pas de chaleur.
4. Ma glycémie en ce moment : ___, stable / en hausse / en baisse.
5. Si je dis « **sucre** », arrêtez — je fais peut-être une hypo.
6. Zones engourdies : ___. Pression large, pas de chaleur. Aussi : articulations raides, plaies, ou étourdissements quand je me lève.

Apportez votre glucomètre ou votre téléphone, et du sucre rapide à portée de la table.

On saute souvent cette étape à la clinique parce que ça semble long à expliquer à un inconnu. Le dire une fois à la maison aide — et la carte s'en charge pour vous.

Choisir un thérapeute au Québec

Vérifiez l'adhésion. Comme la massothérapie et l'orthothérapie ne sont pas réglementées au Québec, le titre n'est pas protégé : n'importe qui peut l'utiliser. C'est l'association dont la personne est membre qui fait foi. La Fédération québécoise des massothérapeutes (FQM), Mon Réseau Plus (RMPQ) et RITMA publient des répertoires de membres. Les plaintes vont à l'association du thérapeute plutôt qu'à un ordre professionnel.

Une question à poser. « Avez-vous déjà traité des clients qui ont une pompe, un capteur ou de l'insuline? » Une bonne réponse ressemble beaucoup à la [page pour les thérapeutes](#).

Assurances, RAMQ et impôts

Reçus d'assurance collective. Les assurances collectives exigent en général un reçu d'un membre en règle d'une association reconnue par votre assureur. Le reçu indique l'association du thérapeute et son numéro de membre. Certains régimes demandent aussi une recommandation médicale. Vérifiez la liste des associations reconnues par votre assureur avant de réserver, pas après.

RAMQ. Le régime public ne couvre ni la massothérapie ni l'orthothérapie.

Impôts. Au Québec, la massothérapie ne donne pas droit au crédit d'impôt fédéral pour frais médicaux — l'Agence du revenu du Canada ne reconnaît les massothérapeutes que dans certaines autres provinces. En général, elle n'est pas admissible au crédit provincial non plus. La physiothérapie, elle, l'est.

Nous ne recommandons ni clinique ni association en particulier. Le point : au Québec, c'est le patient qui fait les vérifications qu'un ordre professionnel ferait ailleurs.

Où trouver de l'aide

- **Diabète Canada** : 1-800-BANTING (1-800-226-8464)
- **Info-Santé** : 811 — une infirmière, 24/7, gratuit
- **Urgence** : 911 — inconscient, convulsions, ne se réveille pas

Chaque chiffre de ces pages est un repère général, pas votre plan. Apportez à votre équipe de soins en diabète ce que vous avez noté — glycémie avant et après, dernière dose et site.

Sources : FQM, « Masser une personne diabétique » (2007) · Fédération québécoise des massothérapeutes (FQM) · Mon Réseau Plus (RMPQ) · RITMA · Desjardins Assurances, guide de réclamation en assurance collective · Agence du revenu du Canada, praticiens autorisés aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux (janvier 2026)

Pour les massothérapeutes et orthothérapeutes

Une liste de questions d'accueil, les adaptations sur la table, et comment reconnaître et traiter une hypo chez une personne vivant avec le type 1.

Cette page s'adresse au thérapeute. Une personne vivant avec le diabète de type 1 n'a pas besoin d'un massage différent — elle a besoin d'un accueil un peu plus long, de quelques adaptations autour de ses

appareils et de ses sites d'insuline, et de quelqu'un dans la pièce qui sait à quoi ressemble une hypo.

Accueil

Demandez, à chaque visite, jusqu'à bien connaître la personne :

- **Pompe ou injections**, l'endroit de la dernière injection ou du site de la pompe
- **La glycémie actuelle et sa tendance** — stable, en hausse ou en baisse
- **Des hypos dans la dernière journée**, surtout une qui a demandé de l'aide
- **Des zones engourdies**, des plaies ou lésions qui guérissent mal, des étourdissements en se levant
- Articulations raides, chirurgie oculaire récente, et le reste de votre questionnaire habituel

La FQM suggère que la personne vérifie sa glycémie avant et après au moins les deux ou trois premières séances.

Sur la table

- **Appareils.** Gardez une main de largeur de peau libre autour du capteur et du site de la pompe. Pas d'huile, pas de pression, pas d'étirement par-dessus.
- **Sites d'insuline.** Évitez les sites d'injection récents et le site de la pompe, et pas de chaleur sur ces zones. Le massage et la chaleur accélèrent tous deux l'action de l'insuline — FIT Canada déconseille de masser un site juste après une dose.
- **Peau engourdie.** Une pression large, à pleine main, plutôt qu'un travail profond en points. Pas de pierres chaudes ni de compresses chaudes sur les zones que la personne ne sent pas.
- **Sucre.** Assurez-vous que son sucre rapide est à sa portée, pas dans son sac.
- **Se relever.** Demandez-lui de s'asseoir au bord de la table avant de se lever.

Si le capteur sonne pendant la séance, ce n'est pas une interruption dont il faut s'excuser. Laissez à la personne le temps de lire l'alarme. Une baisse soudaine pendant qu'elle est couchée sur le capteur peut être une fausse hypo par compression — mais laissez-la confirmer au glucomètre plutôt que de le présumer.

Repérer une hypo

Sueurs, tremblements, agitation soudaine, confusion, élocution inhabituelle, ou simplement un silence. Couchée, détendue, les yeux fermés, la personne peut présenter ces signes sans qu'on les remarque.

Le sucre d'abord, les questions après

- Arrêtez la séance. Aidez la personne à s'asseoir lentement.
- Du sucre rapide — 15 g — puis on revérifie après 15 minutes.
- Inconsciente ou en convulsion : composez le 911. Rien par la bouche.

Ce qui vaut la peine d'être remarqué

- **Bosses aux sites d'injection.** Les bosses caoutchouteuses (lipohypertrophie) sont fréquentes. L'insuline y agit de façon imprévisible; un simple « vous pourriez en parler à votre équipe de soins en diabète » est vraiment utile.
- **Épaules et mains raides.** La capsulite et les mains raides sont fréquentes après de nombreuses années de type 1. Si une épaule raidit depuis des semaines, suggérez un diagnostic par un médecin ou un physiothérapeute, en parallèle de votre travail.
- **Raisons de reporter.** Cétones élevées, hypo grave dans les dernières 24 heures, fièvre ou maladie aiguë, ou plaie et infection dans la zone à traiter.

La plupart des personnes vivant avec le type 1 ont expliqué leur diabète bien des fois. Un thérapeute qui pose les bonnes questions d'emblée, sans en faire tout un plat, est un thérapeute chez qui on revient.

Sources : FQM, « Masser une personne diabétique » (2007) · FQM, « La massothérapie chez la personne diabétique » (2018) · Diabète Québec, « Spa, sauna et massothérapie » · FIT Canada 2020 · Guide d'utilisation Dexcom G7 · Diabète Canada

L'éducation sur le diabète de type 1 de KRKT (KRKT:T1DE), de la Bibliothèque KRKT.

De l'éducation, pas un avis médical. Chaque dose, ratio et cible se décide avec votre équipe de soins en diabète.